

Información Paciente

Nombre : María Flor Gómez Cabrera

Edad : 77a 3m 30d

Dirección : Sargento Menadier # 2556 Dep 304 B

Rut : 4.816.593-1

Fecha Nacto: 14/12/1944

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2203813

Sexo : Femenino

Teléfono : 968379663

N° Epicrisis

298330

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx

Fecha Ingreso : 02/03/2022 00:50

Días Estadía : 42

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 13/04/2022 10:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hematoma intraparenquimatoso

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha ingreso HSR: 01/03/22

Fecha ingreso UTAC: 02/03/22

Fecha de ingreso UCI: 06/03/22

Fecha de reingreso UTAC: 19/03/22

Fecha ingreso Sala: 29/03/22

Paciente de 77 años, diestra, mRs1 con los siguientes antecedentes

- Médicos: Coxartrosis

- Quirúrgicos: niega

- Alergias: niega

- Familiares: niega

- Inmunización: COVID 2 dosis.

- Medicamentos de uso habitual: AINES SOS, Metamizol

- Hábitos: Alcohol: niega. Tabaco: no. Drogas: no.

- Sociales: Analfabeta, vive con hija y nieta, Laboralmente activa (vendedora de cojines en feria libre)

Historia de ingreso:

Paciente sin antecedentes mórbidos conocidos, sin controles médicos de larga data. Última vez vista en su basal el 28/02 a las 17:00 h. Luego fue encontrada por hija a las 22:00 h con disartria, alteraciones del lenguaje, desorientada y con paresia hemicuerpo derecho. Por persistencia de los síntomas fue traída por hija a servicio de urgencias del hospital Sótero del Río, con más de 24 hrs de evolución desde la última vez vista bien.

Ingresó el 01/03 hipertensa (173/68 mmHg), normocárdica (69 lpm), afebril, HGT 134 mg/dL. A la evaluación por equipo de neurología destacó paciente: desorientada en tiempo, respondió ambas preguntas bien, siguiendo órdenes de forma inconsistente, disartria severa, nomina 3/5, repite 5/5, paresia facial central derecha, ESI M3 proximal y M1 distal, EII M3 global, en hemicuerpo derecho M5. NIHSS 9pt (0-0-0-0-0/2-2-0-2-0/0-0-1-2-0).

Se solicitó AngioTC (tomografía computada) de encéfalo que mostró hematoma talámico izquierdo de aproximadamente 11,5 cc de volumen, ICH Score de 1 por vaciamiento ventricular. PCR SARS-CoV-2 negativo. Con esto se decidió hospitalización en UTAC para estudio y tratamiento.

Informe AngioTC cerebro y cuello: Hematoma parenquimatoso agudo talámico derecho con leve vaciamiento ventricular.

Fecha Epicrisis : 13/04/2022 10:01

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 13-04-2022 10:01:49

Página 2 de 5

Alteración del llene de la arteria vertebral izquierda, con una posible estenosis crítica u oclusión en su segmento V1, este último con evaluación limitada debido a artefacto de movimiento. Irregularidad parietal de los segmentos M1 distal de las arterias cerebrales medias, en los segmentos A1 y A2 de las arterias cerebrales anteriores y en la arteria basilar, puede tener origen ateromatoso. Signos de displasia fibromuscular de la arteria vertebral izquierda.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

- 1.- Hematoma intraparenquimatoso talámico izquierdo:
 - ICH 1 punto (vaciamiento ventricular).
- 2.- Antecedentes.

EVOLUCIÓN en UTAC:

NEUROLÓGICO: desde el punto de vista neurológico, la paciente evolucionó inicialmente estable, aunque con periodos de cuadrados de conciencia, interpretados como secundarios a lesión talámica conocida. Se mantuvieron medidas de neuroprotección y manejo de PA (presión arterial) para lograr normotensión. Se pesquisó mirada descendente y nistagmus de convergencia durante su estadía en la UTAC, por lo que se realizó nuevo TC de cerebro de control para descartar compromiso mesencefálico (02/03) el cual impresionó sin cambios respecto al de ingreso. Se inició terapia antihipertensiva (descrito en sección "HEMODINAMIA"), con adecuada respuesta. El día 05/03 presentó episodio de palilalia y mayor compromiso de conciencia, por lo que se decidió realizar EEG y nuevo TC cerebro:

- TC cerebro de control (05/03): Leve aumento de hematoma (11,5 cc a 16 cc), con aumento de edema perilesional, con efecto de masa sobre ventrículo lateral izquierdo similar al del TC del 02/03
- EEG (05/03): Electroencefalograma portátil de 1 hora: Anormal. Muy frecuente lentitud intermitente anterior. Atenuación relativa de voltaje hemisférica izquierda. Disfunción lenta continua generalizada, reactiva.

Se realizó estudio de factores riesgo cardiovascular: Colesterol total 200; HDL 67; LDL 119; triglicéridos 69, Nivel de vitamina B12 de 124 (suplementada), HbA1c 5,3%, TSH 0,62. VDRL: NR

HEMODINÁMICO: al ingreso, con tendencia a la hipertensión severa, por lo que se inició BIC de labetalol y se ajustó esquema antihipertensivo oral con losartán 50 mg c/12 hrs, amlodipino 10 mg/día e hidroclorotiazida 25 mg/día. Todos los antihipertensivos fueron suspendidos de forma transitoria el día 06/03 por sospecha de shock séptico.

HEMATOLÓGICO:

Paciente a su ingreso con hemograma normal. En control del 05/03 se pesquisó caída de al menos 4 puntos de hemoglobina. Sin exteriorización de sangrado. Tacto rectal negativo para melena. Se interpretó como hemodilución (por haber recibido en 24 hrs aprox. 3 Lts de suero fisiológico, con escasa diuresis y mejoría de creatinina de 1,26 a 0,84). Hb de control 10,5 mg/dL. Sin conflicto posterior.

INFECCIOSO: durante la mañana del 06/03 la paciente presentó compromiso súbito de conciencia hasta GCS 6 puntos, con mala mecánica ventilatoria y aspiración de secreción mucopurulenta, por lo que requirió ser intubada y sedada; se decidió traslado a UCI. Se interpretó cuadro como neumonía aspirativa y shock séptico asociado. Dada tendencia a la hipotensión, se suspendieron todos los antihipertensivos y se inició noradrenalina en dosis bajas por vía periférica, con instalación de CVC por anestesia. Se inició ampicilina/sulbactam, pero dado que paciente estaba hospitalizada por 48 hrs, se cambió a tazonam 4,5 gr c/8 hrs, completando 7 días. Se realizó RxTx (radiografía tórax) que mostró broncograma aéreo basal derecha y velamiento de recesos costales. Parámetros inflamatorios al alza.

EVOLUCIÓN en UCI

HEMODINAMIA: paciente se mantuvo estable, intubada, normotensa y normocárdica sin requerimiento de DVA (drogas vasoactivas). Al suspender la sedación evolucionó hipertensa, se manejó con BIC de labetalol y se escaló en antihipertensivos orales. Finalmente se controló la PA con BIC de propofol, amlodipino, losartán, espironolactona y carvedilol. Se logró PAM en rangos aceptables para su patología. El 16/3 inició con taquicardia y ritmo irregular, inicialmente se manejó con VMI y beta bloqueo. Se objetivó FA (fibrilación auricular) con ECG por lo que se inició BIC de amiodarona logrando control de ritmo y frecuencia.

NEUROLÓGICO: hematoma talámico izquierdo con signos de reabsorción y disminución del edema perilesional en TAC del 8/3. Disminución progresiva de la sedación con retorno a vigilia, sin episodios de agitación ni compromiso de conciencia.

Fecha Epicrisis : 13/04/2022 10:01

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 13-04-2022 10:01:49

Página 3 de 5

Obedeciendo en Unidad órdenes de forma parcial, impresionó ser por afasia. Secuelas motoras en hemisferio derecho. Neuroprotección adecuada.

INFECCIOSO: ingresó a UCI por neumonía aspirativa, se completaron 7 días de ampicilina / sulbactam con mejoría de parámetros inflamatorios. CAET (cultivo aeróbico endotraqueal) del 7/3 con desarrollo de flora comensal. El 13/3 presentó peak febril por lo que se pancultivó, sin deterioro hemodinámico por lo que se esperaron resultados de cultivos para iniciar manejo. El 15/3 se elevó PCR a 206 y leucocitos 20840 y se rescató CAET con desarrollo de *Klebsiella aerógenes* BLEE por lo que se inició tratamiento con meropenem.

VENTILATORIO: evolucionó sin conflicto ventilatorio, con PAFI sobre 300 por lo que el 10/3 se intentó weaning, evolucionó con deterioro gasométrico, retención de CO₂ y mala mecánica respiratoria por lo que se reintubó y se realizó traqueostomía el 15/3, completando 24 horas de oxigenación por filtro, sin desaturación, sin uso de musculatura accesoria y sin retención de CO₂.

RENAL: sin conflicto durante toda la hospitalización. Presentó hipokalemia leve que se manejó con carga de potasio. Sin conflicto posterior.

Por estabilidad clínica y logrando extubación, se decidió traslado a UTAC nuevamente.

EVOLUCION EN REINGRESO A UTAC

NEUROLOGICO: Paciente se mantuvo de vuelta a unidad estable en su condición. Se mantuvo con manejo antihipertensivo comentado. En UTAC principalmente se realizó neurorehabilitación; sin nuevos episodios de fluctuación neurológica o comicial. Mejoría principalmente en relación a afasia y paresia ESD. Último TC cerebro s/c del 21/03 con estabilidad en lesión.

REHABILITACION: Paciente en control con equipo. En lo kinesiológico pasando a sillón, SBC máxima asistencia, regular control tronco. En lo fonoaudiológico con Blue dye test negativo sin embargo paciente no cooperaba completamente para deglutir. Con plan de evaluar durante los próximos días necesidad de GTT o no con equipo y familia según seguimiento fonoaudiológico e ingesta terapéutica. Mantuvo SNG fresubin 60 cc. Por último en seguimiento por terapia ocupacional. Usaria de TQT, sin altos requerimientos de oxigenación, con TQT percutánea 8 del 15/03 con cuff y PSG, que utilizó válvula de fonación. Inicio de cierre: 23/03; fue retirada el 28/03 sin complicaciones.

INFECCIOSO: Completó el 23/03 tratamiento por traqueobronquitis secundaria a *Klebsiella aerógenes* con meropenem por 7 días; con buena respuesta. Sin empeoramiento pulmonar, con kinesioterapia respiratoria diaria. Afebril, con baja en parámetros inflamatorios (últimos exámenes del 23/03), sin conflicto posterior.

Estudio microbiológico en hospitalización:

- 02/03: UC (-)
- 12/03 HC I y II negativos
- 13/03 cultivo aspirado traqueal: *Klebsiella aerógenes* 1000000 UFC
- 21/03 HC I y II negativos

CARDIOLOGICO: Durante estadía con tendencia a la hipertensión peri 160 PAS, al momento traslado con Losartán 50 mg bid, amlodipino 10 mg, se aumentó el 22/03 espirolactona a 25 mg cada 12 hrs. Completó BIC de amiodarona por FA (diagnóstico el 17/03), indicándose 200 mg al día. Además con carvedilol 12.5 mg bid para manejo de frecuencia con evolución favorable. Se desestimó durante estadía en Unidad realización de Ecocardiograma, con plan de llevarlo a cabo de forma ambulatoria.

EVOLUCION EN SALA NEUROLOGIA

NEUROLOGICO: Paciente evolucionó en buenas condiciones generales. Hemodinamicamente, afebril, sin requerimientos de oxígeno. En lo neurológico con mejoría progresiva en relación a paresia ESD y afasia. Examen neurológico de traslado: Mental: Vigil, inatenta, desorientada en tiempo, orientada parcial en espacio, cooperadora. Nomina 2/5, repite 2/5, disartria moderada. Sigue órdenes simples. NC: campo visual impresiona conservado por amenaza, isocoria con RFM +/+, OCM impresiona conservado, PFC derecha leve. Motor: Hemiparesia del hemisferio derecho M1 braquial M3+ crural. ROT aumentados a derecha. Plantar extensor a derecha y flexor a izquierda. Sensitivo: Impresiona sin claras alteraciones Cerebeloso: No evaluable.

Fecha Epicrisis : 13/04/2022 10:01

Página 3 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:47

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

REHABILITACION: se mantuvo en seguimiento por equipo.

- FNA: se retiró SNE el 11/04 con buena deglución. Alimentándose con regimen licuado con liquidos claros al momento traslado.
- KNT: Movilidad pasiva ESD, activo-asistida EID. Movilidad activa HCI, contraresistencia en EII. Transición a SBC con mínima asistencia, corrige alineación a estímulo verbal. Destaca buen control de tronco estático, logrando bipedo con asistencia maxima.
- TO: uso de ortesis ESD. En este contexto, y para mejorar cooperacion con equipo, se indicó el 11/04 risperidona 0.25 mg AM - 0.5 mg PM para optimizar regulación conductual.

CARDIOLOGICO: Estable en este apartado, con buen control de frecuencias cardiacas con amiodarona y carvedilol en contexto de FA. Plan de evaluar anticoagulación de forma ambulatoria, ya que es necesario realización de TC cerebro previo a esto.

INFECCIOSO

Con UC+OC del 03/03 polimicrobiano, afebril, sin orinas turbias, sin uso sonda foley. Se decidió conducta expectante. Sin episodios de fiebre, ni retención urinaria, ni elevación de parámetros inflamatorios.

Dada estabilidad clínica y neurológica, se decide traslado a CAPREDENA para completar neurorrehabilitación y tratamiento.

DIAGNOSTICOS DE TRASLADO

- Hematoma talámico izquierdo ICH 1, etiología hipertensiva
- Afasia transcortical motora
- Neumonía aspirativa tratada
- Traqueobronquitis tratada
- Fibrilacion auricular reciente diagnostico
- Hipertensión arterial crónica
- Déficit B12 suplementado
- Coxoartrosis

Diagnóstico de Egreso

Hemorragia Intraencefalica - Talámico Izquierdo, Ich 1 Por Vaciamiento.
Hipertension Esencial (Primaria) - De Reciente Diagnóstico
Neumonia Bacteriana, No Especificada - Aspirativa
Sepsis, No Especificada - Shock Séptico De Origen Infeccioso, Sospecha Foco Pulmonar
Hipopotasemia - Leve
Anemia De Tipo No Especificado -
Afasia Transcortical Motora Secuelar - En Rehabilitación
Fibrilación auricular de reciente inicio - En Control
Disfagia FILS 2 en Rehabilitación -
trastorno de la marcha -

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J:NO

PA 127/68, 63 lpm, 36.3C, 94%.
Diu (+) espontanea en pañal, deposiciones +

Mental: Vigil, inatenta, desorientada en tiempo, orientada parcial en espacio, cooperadora. Nomina 3/5, repite 4/5, disartria moderada. Sigue ordenes simples.

NC: campo visual impresiona conservado por amenaza, isocoria con RFM +/-, OCM impresiona conservado, PFC derecha leve

Motor: Hemiparesia del hemicuerpo derecho M2 braquial M3+ crural. ROT aumentados a derecha. Plantar extensor a derecha y flexor a izquierda.

Sensitivo: Impresiona sin claras alteraciones

Cerebeloso: No evaluable

Fecha Epicrisis : 13/04/2022 10:01

NIHSS: 10 puntos (0-1-0-0-0/1-0-2-0-2/0-1-1-1-1)

Plan Post Alta

Generales:

- Reposo: movilizar por kinesiología.
- Régimen: licuados mas líquidos claros, asistido a 90°
- Rehabilitación: kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional.
- Uso de ortesis: diurno 12:00 hrs a 16:00 hrs, nocturna de 21 hrs a 07:00 hrs. Uso de cuña permanente

Medicamentos:

- Amiodarona 200 mg, 1 comprimido al día por VO
- Amlodipino 10 mg, 1 comprimido al día por VO
- Bromuro de ipratropio, 2 puff cada 6 hrs con aerocámara.
- Carvedilol 25 mg, 1/2 comprimido cada 12 hrs por VO
- Enoxaparina 40 mg, 1 ampolla al día vía SC.
- Espironolactona 25 mg, 1 comprimido al día por VO
- Losartan 50 mg, 1 comprimido cada 12 hrs por VO
- Omeprazol 20 mg, 1 comprimido al día por VO
- Risperidona 1 mg, 0.25mg AM - 0.5 mg PM
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos en caso de dolor o fiebre, por VO

Controles médicos:

- Control con neurología en CDT pasillo 9 en 2-3 semanas tras alta centro rehabilitación. Pedir hora con este documento (epicrisis). Plan control imagenológico de hematoma y definir eventual inicio de anticoagulación oral (por dg. reciente de FA no valvular).
- Control con cardiología en CDT. Pedir hora con interconsulta entregada.
- Control en CESFAM correspondiente para retiro de medicamentos y controles médicos.
- Consultar en servicio de urgencia en caso de síntomas de alarma.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Joaquin Fernández Aldunate

INTERNO

Sebastian Escobar Diaz

Becado/Residente

Amada Marcela Espinosa Maramb

Médico Tratante (Staff)